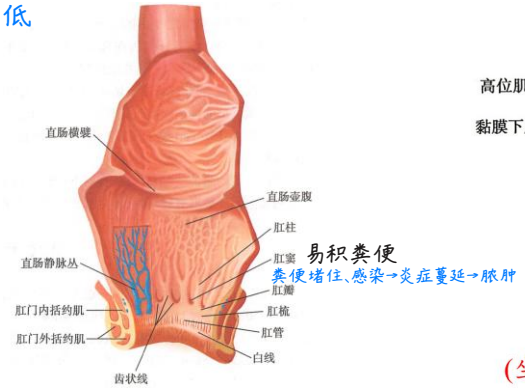
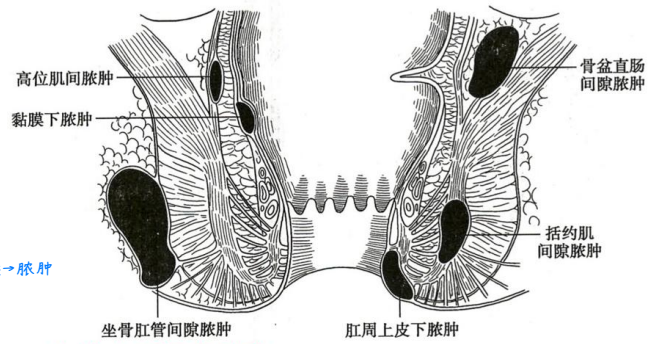
四、直肠肛管周围脓肿

触及波动感→切开引流	局部症状（肛周红肿热痛、持续性跳痛）	全身症状（明显发热、血WBC↑）	
肛周脓肿	明显	不明显	最常见
骨盆直肠间隙脓肿	不明显	明显	最少见
坐骨肛管/直肠间隙脓肿	2个　明显	明显	可有直肠和/或膀胱刺激征

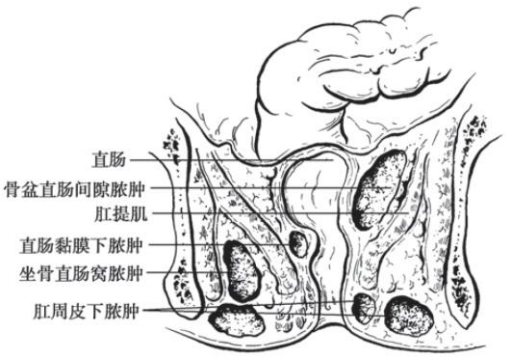
坐骨位置更低

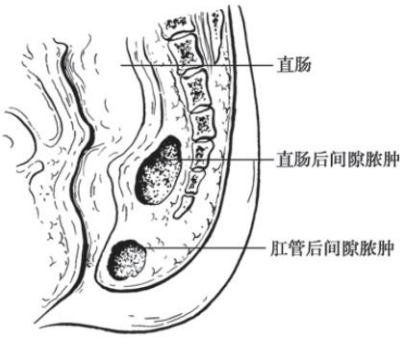


易积粪便
粪便堵住、感染→炎症蔓延→脓肿



(坐骨直肠间隙脓肿)





图中越靠上全身越重
越往下局部越重
中间的坐骨都明显

五、肛瘘（肛周炎症急性期是肛周脓肿、慢性期是肛瘘）

①肛管括约肌间型最常见：瘘管在内外括约肌之间，属于低位肛瘘

②**条索状肿物**，慢性**反复流出脓血性分泌物**

③最重要的是确定肛瘘与肛门括约肌的关系，明确瘘管行程以**减少括约肌损伤**：

大便失禁

低位单纯	**切除**肛瘘（首选）、或**挂线**
低位复杂	**切开**瘘管（复杂肛瘘有多根瘘管、不可能切除——一大堆屁眼）、或切开+**挂线**
高位单纯	**挂线**
高位复杂	切开+**挂线**

- 高位
——括约肌
- 低位

一根瘘管:单纯
多根瘘管:复杂

注意：挂线万能，只有低位单纯能切除（直接切除不会损伤括约肌），复杂就要切开

